

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Constantine 3 Salah Boubnider

Faculté de médecine de Constantine

Laboratoire d'Anatomie Humaine Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

L'ŒSOPHAGE

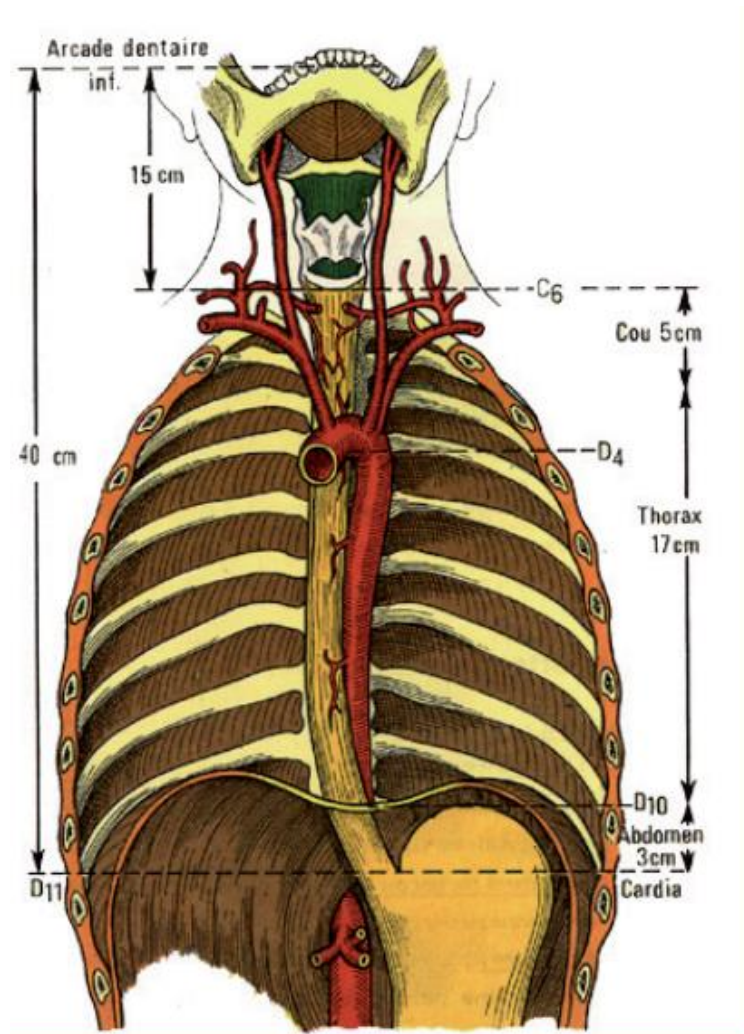
I- **INTRODUCTION** :

Ce long conduit digestif parcourt de part en part le thorax, dans le médiastin postérieur, en situation axiale, prévertébrale.

➔ Mise en place et structure :

L'œsophage relie la partie supérieure du tube digestif, c'est-à-dire le pharynx (qui continue la cavité buccale) avec l'estomac, portion dilatée du tube digestif abdominal.

Il se présente comme un long conduit aplati d'avant en arrière, rubané, large de 3cm, long de 25cm.



II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1) Origine :

L'œsophage fait suite au pharynx au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde à 15 cm de l'arcade dentaire inférieure. Par rapport au rachis cervical, l'œsophage répond à son origine à la 6^e vertèbre cervicale et Plus précisément sur le tubercule de CHASSAIGNAC de l'apophyse transverse de la 6^e vertèbre cervical.

2) Trajet :

L'œsophage descend en arrière de la trachée en situation médiane, il traverse successivement :

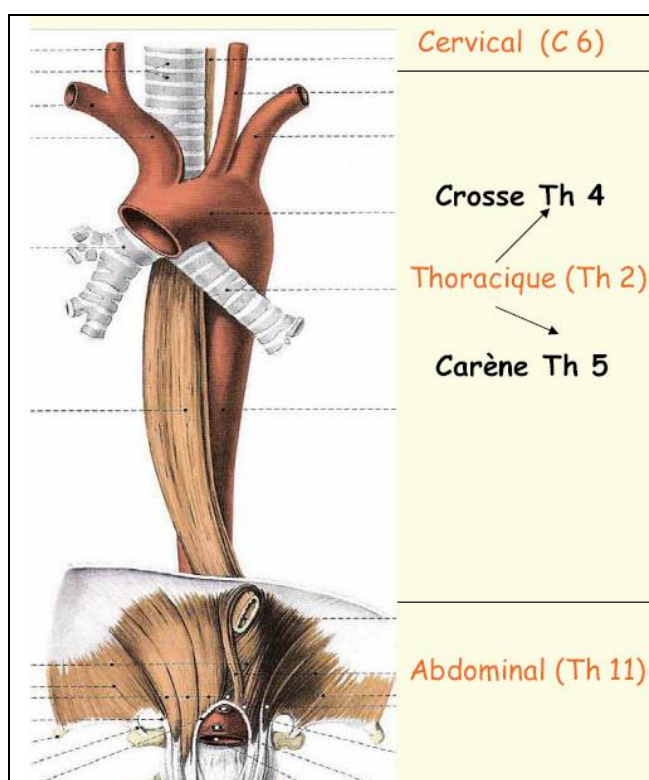
- La partie médiane et inférieure du cou
- Le thorax dans le médiastin postérieur

- Le diaphragme par l'orifice œsophagien
- La partie supérieure de la cavité abdominale

L'œsophage a donc un trajet axial cervico-thoraco-abdominal. Il présente ainsi quatre portions : cervicale, thoracique, diaphragmatique et abdominale.

3) Terminaison :

L'œsophage s'ouvre dans l'estomac au niveau du cardia à 2 cm de la ligne médiane. Le cardia est situé à 40 cm des arcades dentaires à gauche de la ligne médiane et à hauteur de D10.



III- RAPPORTS :

1) L'œsophage cervical :

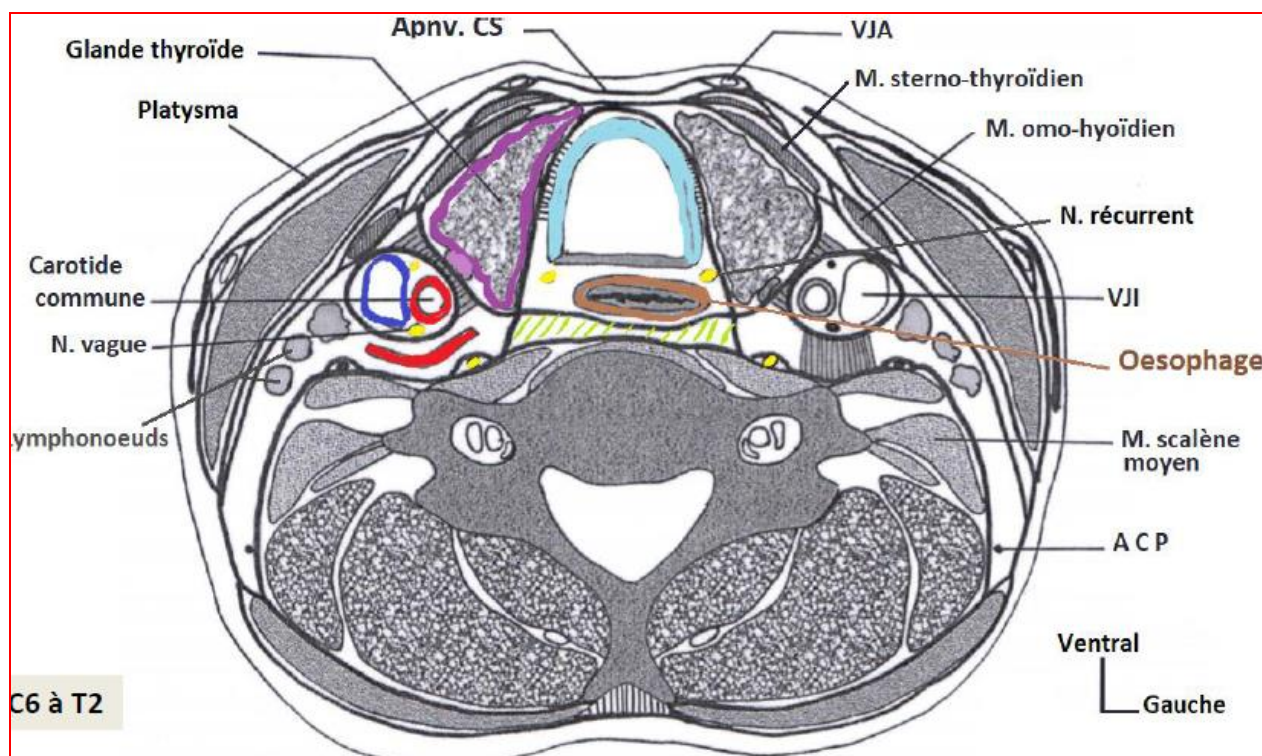
Il est court, profond, prévertébral, rétro-trachéal, et enfermé dans la gaine viscérale.

L'œsophage début en regard du corps de la 6^e vertèbre cervicale où il fait suite au pharynx. Cet orifice supérieur en fente transversale, la bouche œsophagienne, se situe immédiatement en arrière du cartilage cricoïde, dernière pièce du larynx, à 15 cm des arcades dentaires. La bouche marque le relais entre la musculature du larynx, muscle

strié, volontaire, à fibres circulaires, et la musculaire de l'œsophage, muscle lisse, involontaire, à fibres verticales. La transition représente un point faible, amorce des diverticules pharyngo-œsophagiens.

La portion cervicale présente les rapports suivants :

- En avant : la trachée, plus exactement le muscle trachéal : l'œsophage un peu plus large déborde de la trachée à gauche. Le nerf récurrent gauche est pré-œsophagien, le droit répond à l'interstice trachéo-œsophagien. Trachée, œsophage et récurrents sont enveloppés dans une gaine commune, la gaine viscérale.
- En arrière : l'œsophage cervical est très près du rachis. Les corps vertébraux sont tapissés par les muscles prévertébraux, essentiellement le long du cou, recouverts par l'aponévrose pré-vertébrale ; en regard des bords latéraux de l'œsophage, la gaine viscérale détache les cloisons sagittales (de Charpy) qui gagnent l'aponévrose prévertébrale ; elles délimitent, en arrière de l'œsophage, l'espace rétro-viscéral.
- Latéralement : chaque bord de l'œsophage répond au lobe latéral correspondant du corps thyroïde, exactement à la face interne de ce bord. Ce lobe est entouré d'une gaine fibreuse qu'on rattache à la gaine viscérale.
- Plus en dehors, le paquet vasculo-nerveux principal du cou est formé par la veine jugulaire interne en dehors, l'artère carotide primitive en dedans, le X en arrière.



Coupe transversale passant par C6

○ 2- L'œsophage thoracique :

- L'étude des rapports de la portion thoracique de l'œsophage en prenant comme repère la crosse de l'aorte et la crosse de l'azygos. Donc en distingue trois segments de l'œsophage thoracique :

Le segment sus-azygo-aortique, inter-azygo-aortique, sous-azygo-aortique :

a. Le segment sus azygo-aortique :

→ Rapport antérieur :

La trachée uni par un tractus fibreux, le récurrent gauche et la chaîne lymphatique latéro-trachéale en avant de la trachée. Un plan vasculaire prétrachéal, tronc artériel broncho-céphalique à droite, la carotide primitive gauche et le tronc veineux broncho-céphalique gauche.

→ Rapport postérieur :

Colonne vertébrale de D2-D4, muscle pré-vertébraux et aponévrose prévertébrale, chaîne sympathique latéro-vertébrale en arrière et e dehors.

→ Rapport à droite :

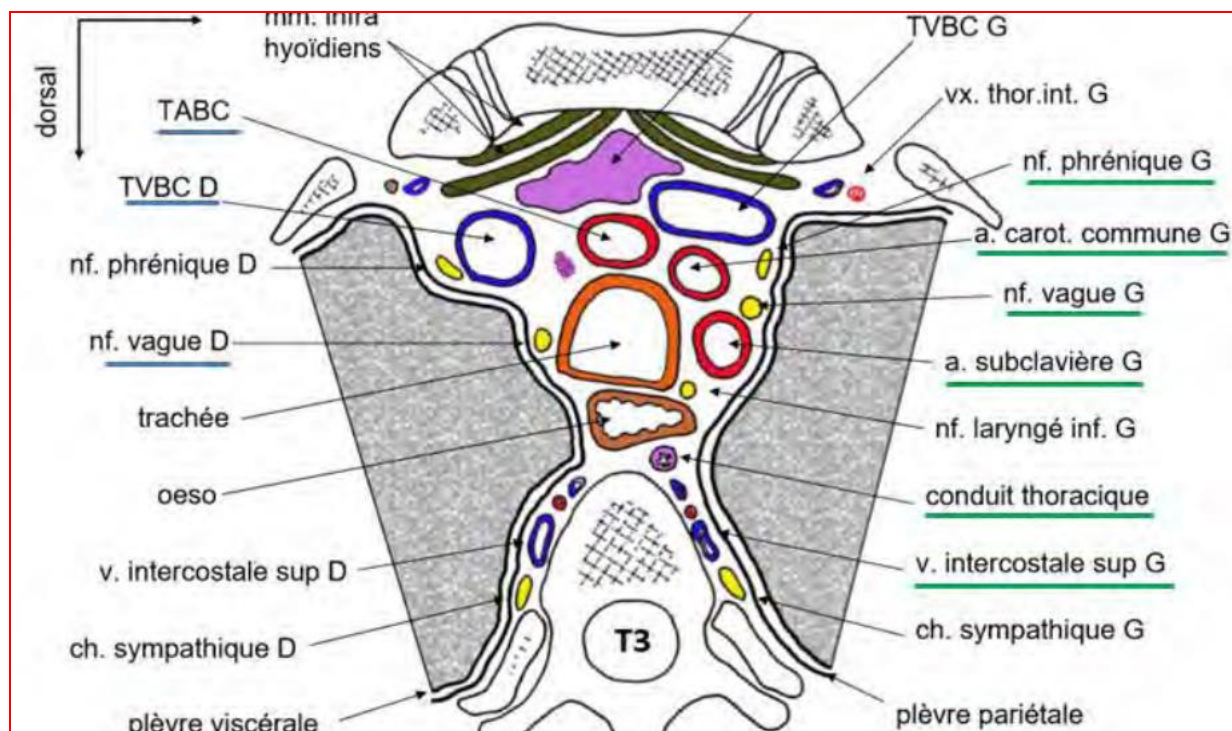
Le X droit, tronc artériel broncho-céphalique, tronc veineux broncho-céphalique et veine cave supérieure, plèvre, médiastin et poumon droit

➔ Rapport à gauche :

Artère sous-clavière, canal thoracique, carotide primitive gauche, veine intercostale supérieure gauche qui se jette dans la TVB gauche, le quadrilatère de BORGERRY :

- En haut : veine intercostale
- En arrière : artère sous-clavière
- En avant : carotide primaire gauche
- En bas : la crosse de l'aorte

Le X gauche, nerf phrénique gauche croise le quadrilatère de BORGERRY, nerf cardiaque de X et du sympathique, la plèvre médiastine recouvre le segment de la face interne du poumon gauche.



Coupe transversale passant par T3

b. Rapport du segment inter azygo-aortique :

➔ Rapport antérieur :

Bifurcation trachéale (branche gauche) ganglion inter trachéo-bronchique.

➔ Rapport postérieur :

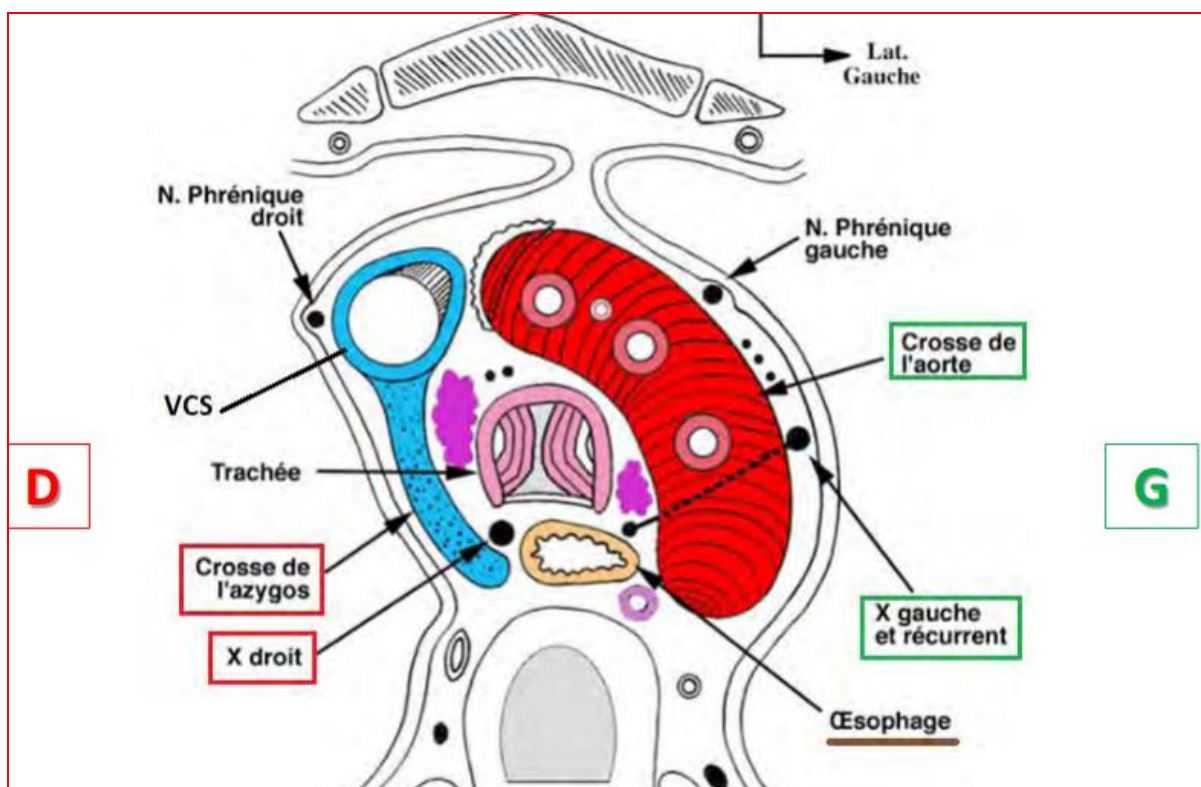
Canal thoracique et la 4^e vertèbre dorsale.

→ Rapport à droite :

La crosse de l'azygos se jette dans la veine cave supérieure, Le X (nerf pneumogastrique) droit, les ganglions de la crosse de l'azygos.

→ Rapport à gauche :

La crosse de l'aorte, le X gauche, récurrent gauche.



Coupe transversale passant par T4

c. Rapport du segment sous azygo-aortique :

→ Rapport antérieur :

Le péricarde, fibreux puis séreux (cul de sac de haller), la face postérieure de l'oreillette gauche est les veines pulmonaires.

au-dessus du péricarde, le triangle trachéo-pulmonaire contenant des ganglions inter-trachéo-bronchique.

Au dessous du péricarde, le diaphragme et l'espace portal limité par le diaphragme en bas, l'œsophage en arrière, le péricarde et les ganglions lymphatiques en avant, le X gauche et pré-œsophagien.

➔ **Rapports latéraux :**

Se font avec le nerf pneumogastrique et le X droit croise la face latérale droite et se dirige vers la face postérieure. Le X gauche croise la face latérale gauche et se dirige vers la face antérieure de l'œsophage. Le nerf pneumogastrique va constituer à ce niveau le plexus péri-œsophagien.

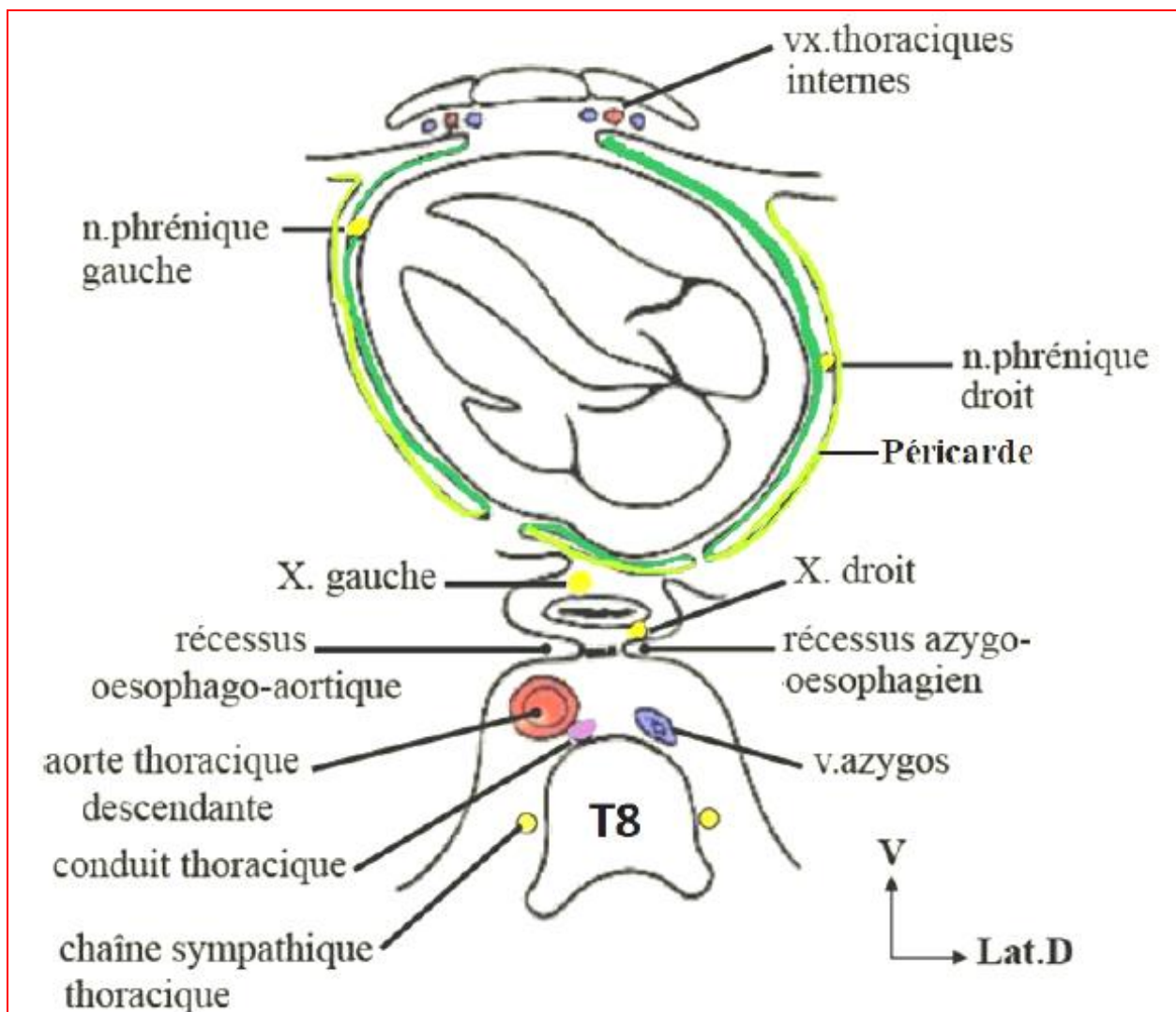
➔ **Rapport avec la plèvre médiastinale :**

La plèvre médiastinale est représentée par :

- Le ligament triangulaire dans les bords internes s'attachant aux bords de l'œsophage.
- Les culs de sacs antérieurs : inter-œsophagiens péricardique peu marqué
- Les culs de sacs postérieurs : rétro-œsophagiens : le droit inter-azygo-œsophagien et le gauche inter-aortique œsophagien.
- réunit par le ligament inter pleural de MOROSOW qui passe en arrière de l'œsophage.

➔ **Rapport postérieur : colonne vertébrale de D4 à D9, entre les deux s'interposent deux plans vasculaire et la plèvre.**

- Plan vasculaire vertical :
 - Aorte thoracique descendante
 - Grande veine azygos
 - Canal thoracique
- Plan vasculaire horizontal :
 - Artère intercostale droite, surtout gauche en bas
 - Veine hémi-azygos, supérieure et inférieure
 - 8^e veine intercostale gauche
 - Le sympathique latéro-vertébral e dehors et en arrière qui donne à ce niveau les nerfs splanchnique thoraco-abdominaux.



Coupe Transversale passant par T8

3- L'hiatus oesophagien ou portion diaphragmatique :

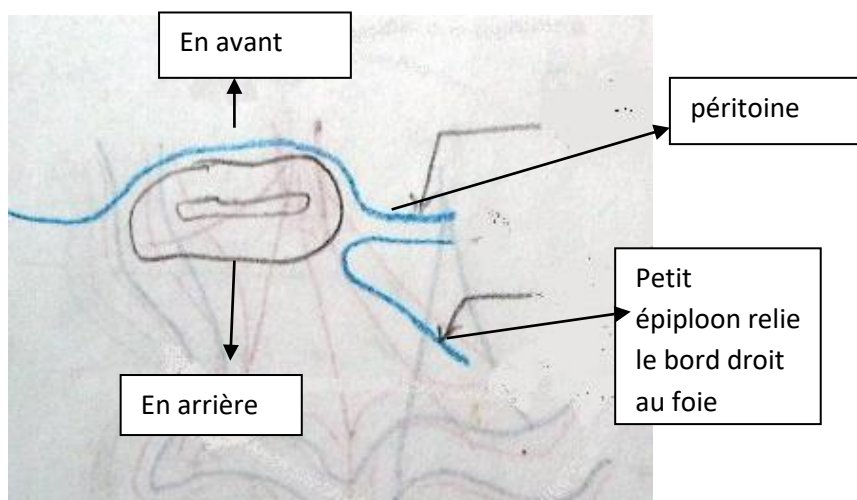
L'œsophage quitte le thorax à la hauteur de D10, versant gauche, par un orifice musculaire elliptique, à grand axe vertical. Cet orifice est formé par l'entrecroisement des piliers (internes) du diaphragme. En fait, la fronde musculaire vient du pilier droit (Allison). Au niveau de l'hiatus, l'œsophage est accompagné par deux nerfs issus du plexus péri-oesophagien : l'un, gauche et antérieur, pneumogastrique gauche ou nerf gastro-hépatique ; l'autre, droit et postérieur, plus gros : c'est le tronc pneumogastrique abdominal.

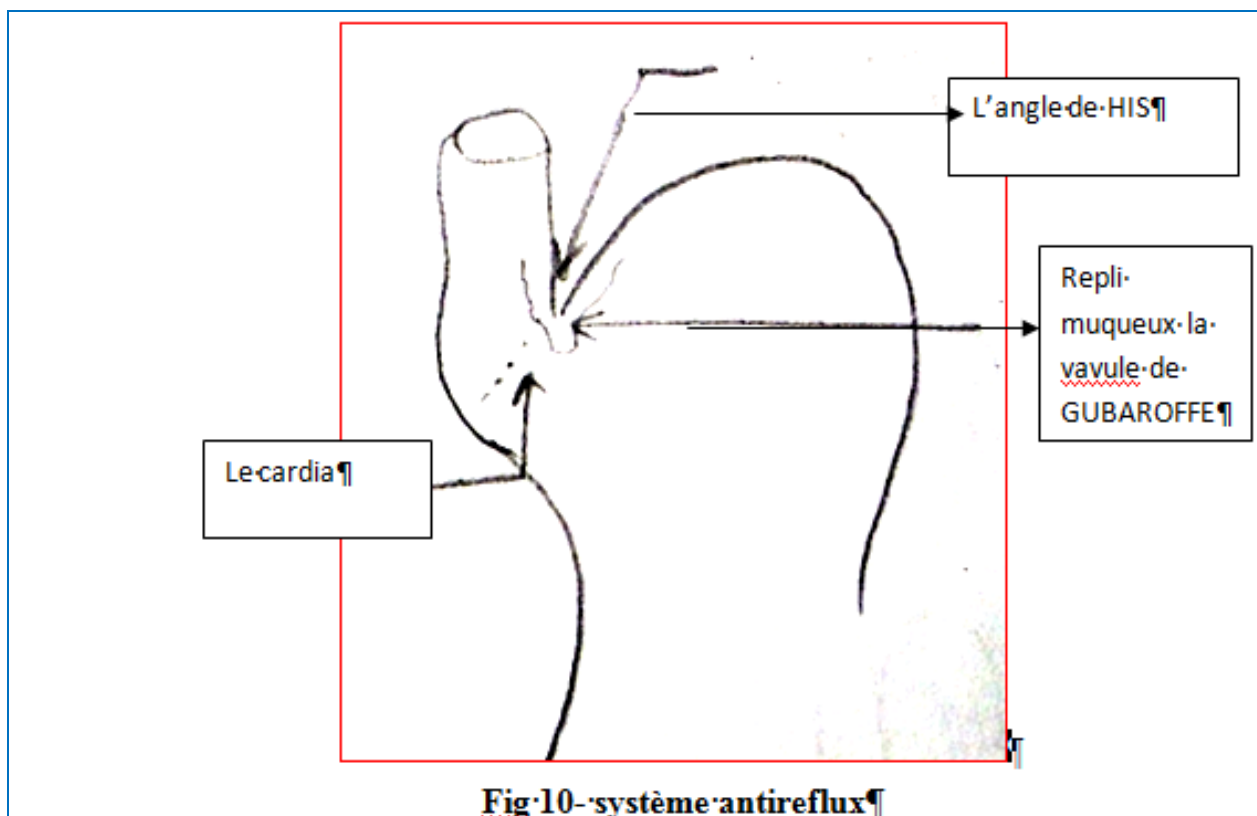
➔ Le canal œsophagien diaphragmatique :

Bien que présentant un rétrécissement diaphragmatique, l'œsophage traverse l'hiatus sans y adhérer. Une membrane fibreuse périphérique, la membrane de Laimer, s'attache en haut au pourtour de l'orifice diaphragmatique, entoure à distance l'œsophage abdominal. Entre cette membrane et l'œsophage s'intercale du tissu conjonctif lâche qui permet au viscère de glisser librement. Sur la membrane fibreuse se perdent des fibres musculaires du diaphragme : fibres de Rouget et de Juvara.

4- L'œsophage abdominal :

Ce segment court (2 à 3 cm), plaqué sur le pilier gauche du diaphragme, n'est recouvert de péritoine que sur sa face antérieure. Son bord droit donne attache au petit épiploon qui gagne le foie. Le nerf pneumogastrique droit est rétro-œsophagien, en regard du bord droit ; le nerf pneumogastrique gauche, pré-œsophagien. Il est assez fréquent d'observer un ou deux rameaux supplémentaires venus du plexus péri-œsophagien. L'orifice terminal, le cardia, ou jonction oeso-gastrique, sera décrit avec l'estomac.





VI- VAISSEAUX ET NERFS DE L'ŒSOPHAGE :

1) Les artères :

Elles viennent de trois sources :

- Les artères œsophagiennes supérieures sont fournies par les thyroïdiennes inférieures (branches des sous-clavières). (Portions cervicale et supra-azygo-aortique)
- Les artères œsophagiennes moyennes ont des petits rameaux qui naissent directement de l'aorte thoracique, face antérieure ; il faut y ajouter des branches des artères bronchiques. (Portions inter et infra-azygo-aortiques)
- Les artères œsophagiennes inférieures reçoivent des diaphragmatiques inférieures (branche interne ou œsophagienne), et des vaisseaux de l'estomac, artère coronaire stomachique en particulier. (Portion abdominale)

Les artères venues de l'abdomen vascularisent les derniers centimètres d'œsophage thoracique.

2) Les veines :

C'est dans la sous-muqueuse du bas œsophage que se réalise une des anastomoses porto-caves essentielles : l'œsophage abdominal, diaphragmatique, et quelques centimètres d'œsophage thoracique se drainent vers la veine porte par la veine coronaire stomachique. Tout le reste de l'œsophage est tributaire du système cave supérieur : veine azygos pour l'œsophage thoracique, veine thyroïdiennes inférieures pour l'œsophage sus-aortique.

3) Les lymphatiques :

Leur extrême diffusion s'explique par le trajet de l'œsophage, et le réseau se jette, de haut en bas :

- Dans les ganglions du cou : chaînes jugulaires internes : chaînes récurrentielle, surtout à gauche
- Dans les ganglions médiastinaux : latéro-trachéaux et inter-trachéo-bronchiques, médiastinaux postérieurs, c'est-à-dire, rétro-œsophagiens.
- Dans les ganglions abdominaux : chaîne coronaire stomachique en particulier.

4) Les nerfs :

Les nerfs végétatifs sont fournis par les pneumogastriques : plexus péri-œsophagien, et par le sympathique : en particulier les premiers ganglions thoraciques (plexus médiastinale postérieur).